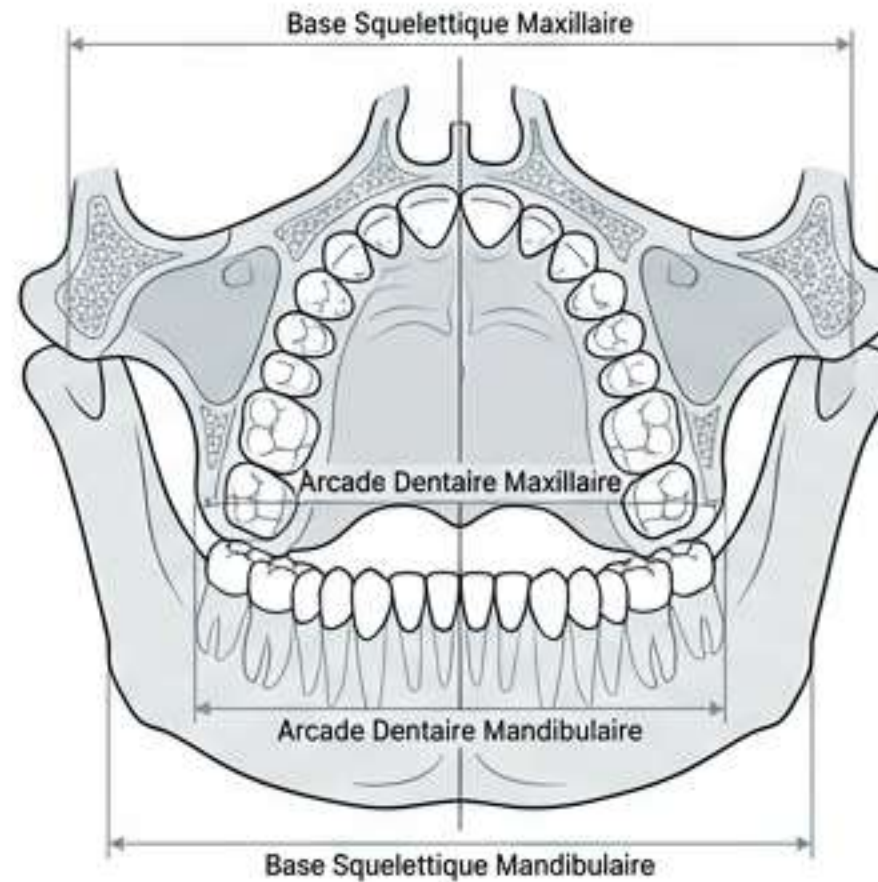


# Diagnostic des Anomalies Dento-Alvéolaires du Sens Transversal



Ces anomalies sont souvent associées à celles dans le sens transversal du système squelettique.

**Difficilement dissociable.** [Predicted – Foundational concept]

Le diagnostic repose essentiellement sur :

- L'examen clinique de l'occlusion des secteurs latéraux.
- L'examen radiographique.

# 1. Endoalvéolie Supérieure : Définition & Classification

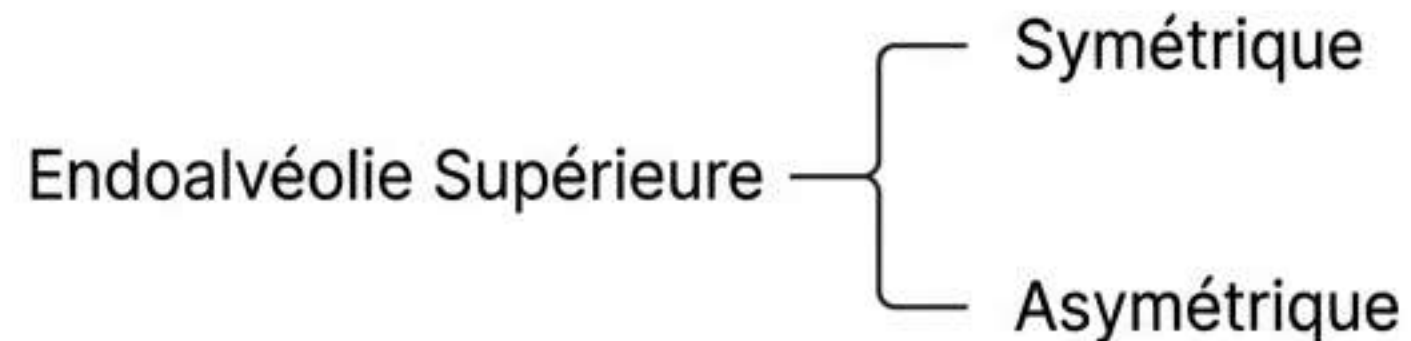
## Définition :

- C'est une anomalie morphologique du sens transversal.
- Caractérisée par une inclinaison linguale des dents d'un ou des deux secteurs latéraux. Ref: Q9

## Association :

- Fréquemment associée à une anomalie cinétique (la latérodéviation).

## Taxonomie Clinique :





# 1-1. Endoalvéolie Symétrique (Type Cinétique)

Avec linguocclusion unilatérale et latéro-déviation



| Signes Faciaux                                                                              | Signes Occlusaux<br>(Denture Temporaire)                                                                                                                    | Signes Occlusaux<br>(Denture Mixte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Déviation du menton en ICM. [Ref: Q11, Q13]</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Occlusion croisée unilatérale s'observe après le suçage du pouce (1-5 ans). Parfois transitoire. [Ref: Q13]</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Arcades séparées :<ul style="list-style-type: none"><li>Arcade mandibulaire normale. [Ref: Q1]</li></ul></li><li>Rapport inter-arcade :<ul style="list-style-type: none"><li>Au repos :<ul style="list-style-type: none"><li>Coïncidence des points inter incisifs. [Ref: Q2]</li></ul></li><li>Chemin de fermeture : Dévie (latéro-déviation).</li><li>En ICM :<ul style="list-style-type: none"><li>Non coïncidence des milieux inter incisifs.</li><li>Linguocclusion unilatérale du côté dévié. [Ref: Q2, Q11]</li></ul></li></ul></li></ul> |



# Signes Téléradiographiques (Endoalvéolie Symétrique)

## Téléradiographie :

- **Cliché Axial** : Permet d'objectiver la symétrie de la mandibule. [Ref: Q11, Q13]
- **De Profil** : Aucun trouble n'est décelable.

## Incidence de Bouvet :

- On a une image des molaires projetées lingualement par rapport à la ligne d'arcade. [Ref: Q2]
- Cette description technique de l'incidence de Bouvet est hautement probable à l'examen. [Predicted – Technical Description]





# 1-1. Endoalvéolie Symétrique (Type Bilatéral)

Avec linguocclusion bilatérale

---

## Caractéristiques Clés :

- La latérodéviation est absente.
- Difficile de différencier cette anomalie d'une endognathie maxillaire. [Ref: Q12, Q15]
- Peu d'encombrement incisif.

---

## Signes Occlusaux :

- En RC et en ICM les milieux coïncident (Pas de latérodéviation). [Ref: Q12]
- Occlusion croisée bilatérale.

---

## Etiologie :

- Situation basse de la langue.
- Déglutition atypique, succion digitale. [Ref: Q12]
- Microglossie et rarement aglossie.



# Diagnostic Différentiel : Endoalvéolie Symétrique

---

## 1. Endognathie Symétrique :

- Souvent confondues car indissociables.
  - Seul l'**encombrement dentaire** permet de pencher vers le diagnostic d'endognathie. [Ref: Q9, Q12]
- 

## 2. Exognathie ou Exoalvéolie Inférieure.

---

## 3. Latéro-glissement : Par présence de prématurités. [Ref: Q7]

---

\* Diagnostic différentiel :

- Endognathie symétrique et endoalvéolie sont souvent confondues car indissociables, seul l'encombrement dentaire permet de pencher vers le diagnostic d'endognathie.
- Exognathie ou exoalvéolie inférieure.
- Latéro-glissement par présence de prématurités.



# 1-2. Endoalvéolie Asymétrique

---

- **Généralités :**

- Anomalie beaucoup plus rare que l'endoalvéolie symétrique.
- Due à une mastication unilatérale. [Ref: Q14]

---

- **Clinique :**

- Palato-version du secteur latéral caractérise un seul coté.
  - Sans troubles cinétiques de l'occlusion. [Ref: Q14, Q16]
  - Les milieux coïncident en RC et en ICM. [Ref: Q1]
  - Linguocclusion unilatérale. [Ref: Q14]
  - Développement asymétrique du maxillaire. [Ref: Q1, Q16]
- 





## 2. Endoalvéolie Inférieure : Clinique

### Définition & Fréquence :

- Anomalie de très faible fréquence. [Ref: Q3]
- Caractérisée par une lingoversion des secteurs latéraux inférieurs.

### Signe Majeur :

- Vestibulocclusion exagérée des secteurs latéraux maxillaires ou innocclusion totale (cas sévères).

### ⚠ Signes Occlusaux (Le Couvercle de Boite) :

- Supraclusion incisive sévère correspond à l'occlusion en 'couvercle de boite'. [Ref: Q6]
- Les bords libres des incisives inférieures sont en contact avec la muqueuse palatine.
- Le préjudice fonctionnel est très important. [Ref: Q3, Q6]





## 2. Endoalvéolie Inférieure : Radio & Etiologie

- **Signes Téléradiographiques :**

De Profil : Etage inférieur fortement diminué; I/F augmenté.  
Incidence de Bouvet : Mandibule inscrite DANS le maxillaire.

CS CamScanner

- Image des molaires et prémolaires se projette lingualemment par rapport à la ligne d'arcade.
- **Etiologie :**
  - Situation haute de la langue + microglossie.
- **Diagnostic Différentiel :**
  - Endognathie mandibulaire.
  - Exognathie ou exoalvéolie supérieure. [Ref: Q8]



# 3. Exoalvéolie Supérieure

---

## Caractéristiques :

- C'est une anomalie rare.
- Une face courte et étage inférieur diminué.
- Une vestibulo-version des dents supérieures latérales.
- Une arcade large avec palais peu profond.
- Une occlusion en 'couvercle de boîte' et une forte supraclusion.

## Etiologie :

- Position haute de la langue + macroglossie.

👉 **Contraste clé:** 'Langue Haute + Macroglossie' (Exo Sup) vs 'Langue Haute + Microglossie' (Endo Inf). [Predicted – Comparison Trap]

## Diagnostic Différentiel :

- Exognathie maxillaire.
- Endoalvéolie inférieure.



# 3-1. Exoalvéolie Inférieure

---

## Généralités :

- Rarement observée.
- S'associe généralement à une forte musculature.

## Signes Occlusaux :

- Lingocclusion uni ou bilatérale avec latéro-déviation.

## Etiologie :

- Situation basse de langue + macroglossie.

## Diagnostic Différentiel :

- Exognathie mandibulaire.
- Endognathie ou endoalvéolie maxillaire.



# Strategic Exam Pattern Analysis

## ☆ Zone Jaune (Haute Fréquence) :

**Endoalvéolie Symétrique :**  
Le mécanisme 'Déviation du menton en ICM' vs 'Coïncidence au repos' est le concept le plus testé [Q1, Q2, Q11, Q13].

**Endoalvéolie Inférieure :**  
Mots-clés "Couvercle de boîte", "Préjudice important", et "Rare" [Q3, Q6].

## ⚠ Zone Rouge (Pièges) :

**Asymétrique vs. Symétrique Unilatérale :**

**Asymétrique :** Milieux Coïncident [Q14].

**Symétrique Unilatérale :**  
Milieux NE coïncident PAS en ICM [Q2].

## → Différenciation :

**Endoalvéolie vs Endognathie =**  
L'encombrement dentaire est le discriminateur clé [Q9, Q12].

# Master Mind Map: Anomalies Transversales

